



Pasuruan, 18 Oktober 2025

Nomor : 897/RSPHS/I-UND/DIR/X/2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan Investigasi Sederhana

Kepada Yth.
Staf Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo (terlampir)
di tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien pada tanggal 16 Oktober 2025 yakni adanya Keterlambatan Pemberian Salep Gentamicin karena Obat Tertinggal oleh Petugas yang tidak diberikan ke pasien, maka Kami akan melakukan pada:

Hari / tanggal : Sabtu, 18 Oktober 2025
Pukul : 11.00 - Selesai
Tempat : Ruang Meeting
Materi : Investigasi sederhana

Demikian undangan ini kami sampaikan, mengingat pentingnya kegiatan tersebut maka **wajib** untuk hadir. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Komite PMKP

Lidia Puspita Kencana, S.K.M.



LAMPIRAN

Nomor : 897/RSPHS/I-UND/DIR/X/2025

Perihal : Undangan Investigasi Sederhana

No	Nama	Jabatan
1.	Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep., M.Kep	PLT. Direktur RS Prima Husada Sukorejo
2.	dr. Latifah, Sp.M	Dokter Spesialis Mata
3.	Sisca Puspitasari S.Kep., Ns	PLT. Kabid Pelayanan
4.	Nur Lailatul Farida, S.Kep., Ns	Kabid Penunjang
5.	Lidia Puspita Kencana, S.K.M.	Komite PMKP
6.	Devi Apriliyanti., Amd Kep	Kepala Ruang IRNA 2B
7.	Elli Yanti Ayu Anggraini, S.Kep., Ns	Perawat IRNA 2B
8.	Anis Purnamasari, S.Kep., Ns	Perawat IRNA 2B
9.	Tatan Lestari, S.Kep., Ns	Perawat IRNA 2B
10.	Asma Yudhi Efendi, S.Kep., Ns	Perawat IRNA 2B



MATERI

I. DATA PASIEN

Nama : **HUNAINAH**

No. RM : 126892

Ruangan : IRNA 2B (**D2B10**)

Umur * : ☐ 0-1 bulan ☐ > 1 bulan – 1 tahun
☐ > 1 tahun – 5 tahun ☐ > 5 tahun – 15 tahun
☐ > 15 tahun – 30 tahun ☒ > 30 tahun – 65 tahun
☐ > 65 tahun

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☒ Perempuan

Penanggung Biaya Pasien : ☐ Pribadi ☐ Asuransi Swasta
☒ BPJS ☐ Lainnya (sebutkan)

Tanggal Masuk RS : Rabu, **15/10/2025**

Petugas Saat Insiden:

1. dr. Latifah, Sp.M
2. Firdhausi Nuzula., Amd Kep (Perawat Poli)
3. Elli Yanti Ayu Anggraini, S.Kep., Ns (Perawat IRNA 2B)
4. Anis Purnamasari, S.Kep., Ns (Perawat IRNA 2B)
5. Tatan Lestari, S.Kep., Ns (Perawat IRNA 2B)
6. Asma Yudhi Efendi, S.Kep., Ns (Perawat IRNA 2B)

II. RINCIAN KEJADIAN

1. Tanggal dan Waktu Insiden

Tanggal : Kamis, **16/10/2025**

2. Insiden : Keterlambatan Pemberian Salep Gentamicin karena Obat Tertinggal oleh Petugas

3. Kronologis Insiden

Hari / Tanggal	Jam	Tindakan	Bukti
15/10/2025	19.00	pasien loadingan atas nama Ny. Hunainah datang dari poli bersama perawat poli dan diterima operan oleh perawat imas (IRNA 2B)	
	20.00	pasien dilakukan tindakan pemasangan infus oleh perawat Ragil	
16/10/2025	12.00	Perawat elli menerima operan dengan perawat firda tanpa fisik RM hanya dibacakan di E-RM karna RM pasien masih di IKO Perawat Elli, menuliskan advice yang dibacakan oleh perawat firda di LOP pasien hunainah	
	12.12.	Perawat Elli menerima tlv dari poli mata agar menurunkan pasien dr. Latifah untuk divisite di poli	



	12.15	Perawat Elli mengoperkan ke perawat Anis untuk menginputkan obat yang sudah di tulis di LOP pasien hunainah	
	12.30	Perawat anis menyuruh perawat tatan menginput obat yang sudah tertulis di LOP	
	13.09	Perawat tatan menginput obat sesuai yang ditulis di LOP pasien	
	13.30	Perawat sif pagi operan dengan perawat sif siang	
	16.00	perawat imas mengambil obat-obatan yang belum terambil di farmasi dan memberikannya ke perawat asma untuk didistribusikan, akan tetapi salah satu obat milik pasien Ny. Hunainah berupa salep gentamicin tersaku dan lupa terbawa pulang hingga ke kosan oleh perawat asma	
17/10/2025	09.00	perawat Anis melakukan asistensi bersama dr. Latifah, saat visite ke pasien Ny. Hunainah dr. Latifah menanyakan terkait salep gentamicin yang sudah diresepkan apakah sudah digunakan tetapi ternyata pasien belum menerima salep tersebut	
	10.00	perawat Asma datang dan membawa salep gentamicin tersebut dan diberikan langsung ke pasien oleh perawat Tatan	

4. Jenis Insiden* :

- ☐ Kondisi Potensial Cedera / KPC
- ☐ Kejadian Nyaris Cedera / KNC (Near miss)
- ☒ **Kejadian Tidak Cedera / KTC**
- ☐ Kejadian Tidak diharapkan / KTD (Adverse Event)
- ☐ Kejadian Sentinel (Sentinel Event)

5. Orang Pertama Yang Melaporkan Insiden*

- ☐ Karyawan : Dokter / Perawat / Petugas lainnya
- ☐ Pasien
- ☒ **Keluarga / Pendamping pasien**
- ☐ Pengunjung
- ☐ Lain-lain(sebutkan)



6. Insiden terjadi pada* :
☒ Pasien
☐ Lain-lain(sebutkan)
Mis : karyawan / Pengunjung / Pendamping / Keluarga pasien, lapor ke K3RS.
7. Insiden menyangkut pasien :
☒ **Pasien rawat inap**
☐ Pasien rawat jalan
☐ Pasien UGD
☐ Lain-lain(sebutkan)
8. Tempat Insiden
(IRNA 2B)
9. Insiden terjadi pada pasien : (sesuai kasus penyakit / spesialisasi)
☐ Penyakit Dalam dan Subspesialisasinya
☐ Anak dan Subspesialisasinya
☐ Bedah dan Subspesialisasinya
☐ Obstetri Gynekologi dan Subspesialisasinya
☐ THT dan Subspesialisasinya
☒ **Mata dan Subspesialisasinya**
☐ Saraf dan Subspesialisasinya
☐ Anastesi dan Subspesialisasinya
☐ Kulit & Kelamin dan Subspesialisasinya
☐ Jantung dan Subspesialisasinya
☐ Paru dan Subspesialisasinya
☐ Jiwa dan Subspesialisasinya
☐ Lain-lain (sebutkan)
10. Unit / Departemen terkait yang menyebabkan insiden
Unit kerja penyebab
11. Akibat Insiden Terhadap Pasien* :
☐ Kematian
☐ Cedera Irreversibel / Cedera Berat
☐ Cedera Reversibel / Cedera Sedang
☐ Cedera Ringan
☒ **Tidak ada cedera**
- Grading Risiko Kejadian*** (Diisi oleh atasan pelapor) :
☐ **BIRU** ☒ **HIJAU** ☐ **KUNING** ☐ **MERAH**

NB. * = pilih satu jawaban

I. ANALISA PENYEBAB INSIDEN

Dalam pengisian penyebab langsung atau akar penyebab masalah dapat menggunakan Faktor kontributor (bisa pilih lebih dari 1)

FAKTOR KONTRIBUTOR EKSTERNAL / DI LUAR RS	
a. Regulator dan Ekonomi b. Peraturan & Kebijakan Depkes c. Peraturan Nasional d. Hubungan dengan Organisasi lain	
FAKTOR KONTRIBUTOR ORGANISASI & MANAJEMEN	
Organisasi & Manajemen	a. Struktur Organisasi b. Pengawasan c. Jenjang Pengambilan Keputusan
Kebijakan, Standar & Tujuan	a. Tujuan & Misi b. Penyusunan Fungsi Manajemen c. Kontrak Service d. Sumber Keuangan e. Pelayanan Informasi f. Kebijakan diklat g. Prosedur & Kebijakan h. Fasilitas & Perlengkapan



	i. Manajemen Risiko j. Manajemen K3 k. Quality Improvement
Administrasi	Sistem Administrasi
Budaya Keselamatan	a. Attitude kerja b. Dukungan manajemen oleh seluruh staf
SDM	a. Ketersediaan b. Tingkat Pendidikan & Keterampilan Staf yang berbeda c. Beban Kerja yang optimal
Diklat	Manajemen Training Pelatihan / <i>Refreshing</i>
FAKTOR LINGKUNGAN KERJA	
Desain dan Bangunan	a. Manajemen Pemeliharaan b. Penilaian Ergonomik c. Fungsionalitas
Lingkungan	a. Housekeeping b. Pengawasan Lingkungan Fisik c. Perpindahan Pasien antar Ruangan
Peralatan / sarana / prasarana	a. Malfungsi Alat b. Ketidakterediaan c. Manajemen Pemeliharaan d. Fungsionalitas e. Desain, Penggunaan & Pemeliharaan peralatan
FAKTOR KONTRIBUTOR : TIM	
Supervisi & Konsultasi	a. Adanya kemauan staf junior berkomunikasi b. Cepat Tanggap
Konsistensi	a. Kesamaan tugas antar profesi b. Kesamaan tugas antar staf yang setingkat
Kepemimpinan & Tanggung Jawab	a. Kepemimpinan Efektif b. Job Desc Jelas
Respon terhadap Insiden	Dukungan <i>peers</i> setelah insiden
FAKTOR KONTRIBUTOR : PETUGAS	
Kompetensi	a. Verifikasi Kualifikasi b. Verifikasi Pengetahuan & Keterampilan
Stressor Fisik dan Mental	a. Motivasi b. Stresor Mental: efek beban kerja beban mental c. Stresor Fisik : efek beban kerja = gangguan Fisik
FAKTOR KONTRIBUTOR : TUGAS	
Ketersediaan SOP	a. Prosedur Peninjauan & Revisi SPO b. Ketersediaan SPO c. Kualitas Informasi d. Prosedur Investigasi
Ketersediaan & akurasi hasil test	a. Test Tidak Dilakukan b. Ketidaksesuaian antara interpretasi hasil test
Faktor Penunjang dalam validasi alat medis	a. Ketersediaan, penggunaan, reliabilitas b. Kalibrasi
Desain Tugas	Penyelesaian tugas tepat waktu dan sesuai SPO
FAKTOR KONTRIBUTOR : PASIEN	
Kondisi	Penyakit yang kompleks, berat, multikomplikasi
Personal	a. Kepribadian b. Bahasa c. Kondisi Sosial d. Keluarga
Pengobatan	Mengetahui risiko yang berhubungan dengan pengobatan
Riwayat	a. Riwayat Medis b. Riwayat Kepribadian c. Riwayat Emosi
Hubungan Staf dan Pasien	Hubungan yang baik
FAKTOR KONTRIBUTOR KOMUNIKASI	
Komunikasi Verbal	a. Komunikasi antar staf junior dan senior b. Komunikasi antar Profesi c. Komunikasi antar Staf dan Pasien d. Komunikasi antar Unit Departemen
Komunikasi Tertulis	Ketidaklengkapan Informasi



ABSENSI

Daftar Hadir
Undangan Investigasi Sederhana

Tempat : R MEETING SEKRETARIAT
Location

Tanggal dan : Sabtu, 2025-10-18 11:00:00
Jam
Date Time

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	TANDATANGAN	
1	Arindha Rahma Putri, S.Psi		administrasi		
2	Nur Lailatul Farida, S.Kep.,Ns	Penunjang Medis	Kabid		
3	Heni Indra Wulansari, S.Kep., Ns., M.Kep	RSPHSKR	Kepala Bidang Pelayanan Medik RSPH Sukorejo		
4	Siti Maysaroh, Amd.Kep	RSPHSKR	Kepala Ruang IRNA 3A RSPH Sukorejo		
5	- LIDIA PUSPITA KENCANA, S.K.M.	RS Prima Husada Sukorejo	Mutu		
6	FARHAH NAHDIA KAMILAH, A.Md.Kep.	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		
7	Isna Setya Wati, S.Kep.Ns	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		
8	Ns.Novita Febri Setiyani,S.Kep	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		
9	Devi Apriliyanti, Amd.Kep	RS Prima Husada Sukorejo	Perawat		
10	Amanda Fharadita Olivia Rakhmad, S.KM.	MUTU	PESERTA		
11	Tatan lestari s.kep.ns	Irna 2 b	PESERTA		
12	Tatan lestari s.kep.ns	Irna 2 b	PESERTA		
13	Elli Yanti Ayu Anggraini	IRNA 2B	PESERTA		
14	Asma	Perawat 2B	PESERTA		
15	Sisca Puspitasari, S. Kep, Ns.	RS Prima Husada Sukorejo	Plt Kabid Pelayanan		

Malang, 18 Oktober 2025

arindha.raihan@gmail.com

NOTULENSI

HARI / TANGGAL

: SABTU / 18 OKTOBER 2025

PUKUL

: 11.00 WIB – SELESAI

JENIS MEETING

: INVESTIGASI SEDERHANA

TEMPAT

: RUANG MEETING

Berikut hasil notulen :

No	Penjelasan
1.	Pokok Bahasan : Investigasi Sederhana terkait Keterlambatan Pemberian Salep Gentamicin karena Obat Tertinggal oleh Petugas Masalah : Pasien tidak mendapatkan terapi (salep) karena obat tersebut tertinggal di saku baju perawat jaga (shift siang) dan terbawa pulang Akar Masalah: Keterlambatan Proses Obat (Input ke Pengambilan): - Advis obat baru diinput oleh Tatan pada jam 13.00. - Obat tersebut baru diambil dari farmasi oleh perawat shift siang pada jam 16.00 (terjadi jeda 3 jam). Kegagalan Administrasi dan Handover: - Setelah obat diambil jam 16.00, obat tersebut disimpan di saku perawat dan tidak segera diberikan ke pasien - Terjadi kegagalan saat handover (operan jaga); advis tambahan dan fakta bahwa obat sudah diambil (namun masih di saku) tidak tersampaikan ke shift berikutnya. - Akibatnya, obat tersebut terbawa pulang oleh perawat shift siang. Masalah Profesionalisme dan Kepatuhan - Perawat yang bertugas tidak hafal pasien ("gatau nomor pasien") saat hendak melakukan tindakan (injeksi) - Sistem Tim Tidak Berjalan: Pembagian tim (Tim A, Tim C) di IRNA tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan tanggung jawab per pasien menjadi tidak fokus (loss) dan berkontribusi pada kegagalan handover.
	Keterangan : Investigasi Sederhana Kejadian Tidak Cedera (KTC - Grading Hijau) di IRNA 2B.
	PIC : - Perawat IRNA 2B - Kepala Ruang IRNA 2B - Kepala Instalasi Farmasi - Komite PMKP - Kepala Bidang Pelayanan
	Rencana Tindak Lanjut : - Setiap advis baru harus segera ditindaklanjuti, di-update di DPO, dan obat segera diambil serta diberikan - Perbaiki Sistem Handover: - Melakukan sosialisasi ulang mengenai proses handover yang benar. - Handover harus dilakukan dengan berkeliling ke pasien dan berkumpul di nurse station untuk memastikan semua informasi tersampaikan. (Harus disertakan bukti foto setelah rapat investigasi sederhana) - Menjalankan kembali sistem tim (Tim A/C) secara efektif untuk memperjelas fokus dan tanggung jawab perawat per pasien. (Sosialisasi terkait PPJA dalam pembagian tim dan supervisi oleh kapid pelayanan) - Perbaiki alur kerja:



Jika ada input obat baru yang mepet dengan pergantian shift, harus segera diinformasikan di grup WA dan di-tag ke shift pengganti untuk memastikan obat diambil dan diberikan.

Pasuruan, 18 Oktober 2025

Pemimpin Rapat
PLT. Direktur RSPH Sukorejo



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.,
M.Kep.

Notulis

Lidia Puspita Kencana, S.K.M.



DOKUMENTASI

